جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ميرفت محمد سيد عبد المجيد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** امبابه **العنوان :** مممممممممممم
رقم البطاقة : 28202020101781 **رقم التليفون :** 01188321495 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 10-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 02-02-1982 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ميرفت محمد سيد عبد المجيد
National ID: 28202020101781

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



ميرفت
محمد سيد عبدالمجيد
٦ ش سليمان من محمد
امبابة - الجيزه

٢٨٢٠٢٠١٠١٧٨١

JM0742510

٢٨٢٠٢٠١٠١٧٨١ ٢٠٢٢/٠٧
حاصلة على دبلوم فنى تجارى

أنثى مسلمة متزوجة
سلامه كمال محمد سعد

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٧/٢٧

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مستشفى أورام دار السلام
قسم الباثولوجى

Pathology Report

Name: مرفت محمد سيد عبد المجيد Age:37 years.

Clinical data: breast mass

Specimen type: Tru cut Biopsy.

Date (Received):21/3/2021 Date(reported): 8/4/2021

Lab. Number: 525/21(IPT) Hospital Number: مبادرة

Gross Description:

Multiple greyish white cores the longest 2cm totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR & HER2
ER clone (1E2).
PR clone (SP1).
HER-2 CLONE (4B5).

Microscopic Examination:

Histopathological examination of sections prepared from the biopsy received reveals an infiltrating malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate

- Microscopic examination of ER stained slide show moderate nuclear stain in 60% of the tumor cells.
- Microscopic examination of PR stained slide show moderate nuclear stain in 80% of the tumor cells.
- Microscopic examination of HER2 stained slide show faint staining in 10% of tumor cells with incomplete membranous staining.

Diagnosis:

Right breast mass, tru cut biopsy:

- **Invasive duct carcinoma grade II**
- **ER: Positive (6/8).**
- **PR: Positive (7/8).**
- **HER-2: negative (score 1+) .**

Prof. Dr. Gamal Abd El Aal
Dr. Rana Fathy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Pathology Report

Name: مرفت محمد سيد Age: 37years.

Clinical data: Left breast cancer, the patient doesn't receive chemotherapy.

Specimen type: Left breast wide local excision (WLE), intra mammary lymph node + sentinel lymph node, extra superior margin and axillary clearance.

Date (Received): 26/4/2021 **Date(reported): 5/5/2021**

Lab. Number:902 /21 **Hospital Number:**

Gross description:

4 specimens were received:

A) Sector of mammary tissue measured 10x9x7cm designated by sutures (LL, SS) and a wire. Cut section revealed a well-defined firm greyish white nodule measured 0.7x0.5cm (totally submitted).

Sentinel lymph node SLN: A separate small fibrofatty tissue piece measuring 2.5x2cm, totally submitted.

B) Left WLE specimen measured 10x7.5x2cm covered by skin ellipse measured 4x2. Cut section revealed a rubbery to firm greyish white mass measured 1.5x1.5cm located away from superficial, deep, medial, lateral, superior, inferior margins (0.5, 0.7, 4, 2, 4, 2cm) respectively.

C) Axillary clearance: A fibrofatty tissue piece measured 4.5x3.5cm containing 16 lymph nodes up to 2.5cm.

D) Extra superior margin: A skin tissue piece measured 6x2cm

Microscopic Examination:

Sections examined revealed an infiltrating malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells with moderate atypia. Stromal desmoplasia is moderate. Unremarkable insitue components. Inconspicuous perineural invasion Occasional lymphovascular emboli. Free margins. Positive intra (1/1) mammary lymph node

Positive metastatic invasion in (1/16) axillary lymph nodes, with no extra capsular invasion. Total nodules (2/17).

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. ***Chest:***

A reported case of left breast mass.

- Left breast inner quadrant small lesion measuring 1 X 0.5 cm.
- Prominent left axillary level I lymph nodes the largest measures 1 cm.
- Right lower lung lobe calcified nodule (likely post granulomatous sequel).
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Aberrant right subclavian artery (normal anatomical variant).

2. ***Abdomen and pelvis:***

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

CT Scan [[DOCTYPE:CT_SCAN]]

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.

OPINION:

- ***Left breast small mass.***
- ***No definite of pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.***

Dr.Mohammed Mohsen, MSc.

Dr. M. Gomaa, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Diagnosis:

Left breast wide local excision (WLE) + SLN + Axillary clearance + extra superior margin:
Invasive duct carcinoma grade II
Occasional lymphovascular emboli
Free margins
Free extra superior margin
Positive intra mammary lymph node (1/1)
Positive metastatic invasion in (1/16) axillary lymph nodes, with no extra capsular invasion.
Total lymph nodes status (2/17).
Stage: pT1, pN1, pMx.

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Abdulrahman Ibrahim

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECHON SUPPORT

تاريخ الاصدار :18-4-2021

جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين ان

السيد (ة) ميرفت محمد سيد بطاقة رقم 28202020101781

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى

وشكرا

تاريخ الطباعه :11-12-2022

: إفادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

يعتبر هذا الخطاب ساري لمدة شهر من تاريخ الاصدار

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

اوراق استكمال علاج

Non-HIO Letter [[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

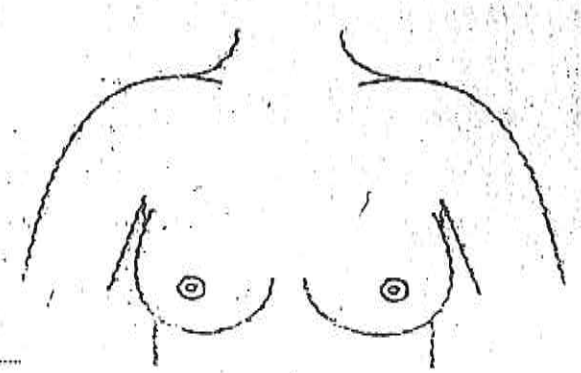
ID ٨٠٠٠٠٠٧٨١
١٠٦٤٦٤٠١٩

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
« هرمل » سابقا

Name :
Age :
No.:

MDT FORM

Clinical data :



Lt BCS :

Tc N+/? M0 ER 6/8
(5-) PR 7/8
HER2 1+

Reason of discussion:

MDT Outcome and Plan

Signature :